Antibiothérapie des infections cervicales profondes d'origine pharyngée chez l'enfant et l'adulte

Diaporama SPILF
à partir des recommandations de la SFORL 2024

Jeu de diapositives réalisées par le comité des référentiels de la SPILF décembre 2024

Cadre nosologique

- Adénite
- Abcès péri amygdalien
- Abcès péri-pharyngé ou rétro-pharyngé
- Cellulite cervicale profonde extensive
- Médiastinite nécrosante descendante

Les points-clé : microbiologie

- Réalisation de prélèvements microbiologiques profonds avant initiation de l'antibiothérapie sauf :
    - Urgence thérapeutique (sepsis ou choc septique)
    - Adénites aigües non compliquées traitées en ambulatoire
- Réalisation d'hémocultures si sepsis ou choc septique

Adénites (adulte)

Cibles bactériologiques: Streptocoque du groupe A (SGA), *Staphylococcus aureus* (SA)

Antibiothérapie initiale probabiliste	**Alternatives en cas d'allergie vraie aux pénicillines** [1]	**Antibiothérapie ciblée en fonction de la documentation microbiologique PAR ORDRE DE PREFERENCE**
Amoxicilline/ac clavulanique [2] En cas de mauvaise évolution: avis infectiologique	**Céfazoline** En cas d'allergie contre indiquant les bêtalactamines: • **Clindamycine** ou • **Linézolide**	**SGA** : 1- Amoxicilline 2- Clindamycine **SAMS** : 1- Cefalexine 2- Clindamycine 3- Cotrimoxazole **SARM** : 1- Clindamycine 2- Cotrimoxazole 3- Linézolide Relais PO dès évolution clinique favorable [3]

[1] Wijnakker R *et al.* 2023

[2] PO d'emblée sauf hospitalisation, impossibilité de la prise per os, signes de gravité

[3] Evolution clinique favorable : Apyrexie, reprise de l'alimentation orale

Abcès péri ou rétro pharyngé – Abcès péri-amygdalien (adulte)

Cibles bactériologiques : SGA, *Streptococcus milleri*, autres streptocoques, SA, *S. pneumoniae*, *Fusobacterium spp*., *Prevotella spp*., *Peptococcus spp*., *Bacteroïdes spp*., *Porphyromonas spp*., *Finegoldia spp*.

Antibiothérapie initiale probabiliste	**Alternatives en cas d'allergie vraie aux pénicillines**[1]	**Antibiothérapie ciblée en fonction de la documentation microbiologique PAR ORDRE DE PREFERENCE**
Amoxicilline/ac clavulanique [2] + 1 dose unique de gentamicine si choc septique	**Céfazoline** + **Métronidazole** En cas d'allergie contre indiquant les bêtalactamines : **Linézolide** + 1 dose unique de gentamicine si choc septique	1 - Amoxicilline/ac. clav 2 - Clindamycine 3 - Linézolide Relais PO possible dès évolution clinique favorable[3]

[1] Wijnakker R *et al*. 2023
[2] PO d'emblée sauf hospitalisation, impossibilité de la prise per os, signes de gravité
[3] Evolution clinique favorable : Apyrexie, reprise de l'alimentation orale

Synthèse réalisée par la SPILF

Cellulite cervicale profonde extensive - Médiastinite nécrosante descendante (adulte)

Cibles bactériologiques : SGA, *Streptococcus milleri, S. constellatus, S. intermedius, S. agalactiae, S. mitis, SA, S. pneumoniae, Fusobacterium spp, Prevotella spp, Peptococcus spp, Peptostreptococcus spp, Bacteroïdes spp*

Antibiothérapie initiale probabiliste	Alternatives en cas d'allergie vraie aux pénicillines[1]
Amoxicilline/ac clav Ou **Céfotaxime/Ceftriaxone** **+ métronidazole** **+ Clindamycine** si signes toxiniques[2] + 1 dose unique de gentamicine si choc septique	Allergie aux pénicillines: **Céfotaxime/ Ceftriaxone** + **Métronidazole** **+ Clindamycine** si signes toxiniques[2] En cas d'allergie croisée avec céphalosporines MAIS sans hypersensibilité retardée grave[3] : **Méropénème** **+ Clindamycine** si signes toxiniques[2] En cas d'allergie contre- indiquant les BLactamines **Lévofloxacine + Linézolide** ET avis infectiologique + 1 dose unique de gentamicine si choc septique

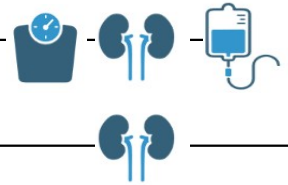
[1] Wijnakker R *et al*

Synthèse réalisée par la SPILF

[2] Si évolution rapide/ signes toxiniques : rash, troubles digestifs, confusion, hypotension

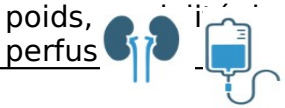
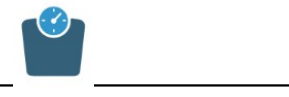
[3] DRESS syndrome (Syndrome d'hypersensibilité médicamenteuse), syndrome de Stevens Johnson, épidermolyse nécrosante suraiguë de Lyell , PEAG (pustulose exanthématique aiguë généralisée), vascularite

Posologies recommandées chez l'adulte (1)

Modalités d'administration des antibiotiques dans le cadre des infections cervicales profondes d'origine pharyngée chez l'adulte : posologies, voies d'administration, rythme, particularités : posologies, voies d'administration, rythme, particularités			
Antibiotique	**Adaptations :** fonction rénale, poids, modalité de perfusion	**Posologie totale journalière de référence pour une fonction rénale normale (clairance entre 60 et 90 ml/min) et un IMC normal (entre 18 et 30 kg/ m²)**	**Particularités/ remarques**
Amoxicilline		**Adénites** **IV** : administration discontinue : 80 mg/kg/j en 6 administrations (perfusions de 30 à 60 min toutes les 4 h) **PO** : 80 mg/kg/j en 3 à 4 prises de 2 à 3g	**IV** : si ≥ 12 g/j, perfusion continue : STP **PO** : au-delà de 9 g/j : STP
		Abcès péripharyngé ou rétropharyngé, cellulite, abcès péri-amygdalien, médiastinite **IV** : administration discontinue : 100 mg/kg/j en 6 administrations (perfusions de 30 à 60 min toutes les 4h) **PO** : 100 mg/kg/j en 3 à 4 prises de 2 à 3g	
Amoxicilline /ac. clavulanique		**Adénites** **IV** : administration discontinue : 80 mg/kg/j d'amoxicilline en 4 à 6 administrations, sans dépasser 1200 mg d'acide clavulanique/j **PO** : 80 mg/kg/jour d'amoxicilline en 3 à 4 prises de 2 à 3g	**IV** : amoxicilline/ac. clav : 1g/200mg ou 2g/200mg **PO** : amoxicilline/ac. clav:1g/125mg
		Abcès péripharyngé ou rétropharyngé, cellulite, abcès péri-amygdalien, médiastinite **IV** : administration discontinue : 100 mg/kg/j d'amoxicilline en 4 à 6 administrations, sans dépasser 1200 mg d'acide clavulanique/j **PO** : 100 mg/kg/jour d'amoxicilline en 3 à 4 prises de 2 à 3g	
Céfazoline		**IV**: 100 mg/kg/j en administration continue (stabilité jusqu'à 12h) après dose de charge de 2g sur 1h ou discontinue en 3 administrations (perfusions de 60 min toutes les 8 h)	si ≥ 6g/j : STP
Céfalexine		**PO :** 2g toutes les 8h	

*STP : suivi thérapeutique pharmacologique

Posologies recommandées chez l'adulte (2)

Modalités d'administration des antibiotiques dans le cadre des infections cervicales profondes d'origine pharyngée chez l'adulte : posologies, voies d'administration, rythme, particularités : posologies, voies d'administration, rythme, particularités			
Antibiotique	**Adaptations :** fonction rénale, poids, [illegible] perfus	**Posologie totale journalière de référence pour une fonction rénale normale (clairance entre 60 et 90 ml/min) et un IMC normal (entre 18 et 30 kg/ m²)**	**Particularités/ remarques**
Ceftriaxone		**IV**: 35 mg/kg/j en 1-2 perfusion de 2g maximum	
Cefotaxime		**IV:** 100mg/kg/j en administration continue (stabilité jusqu'à 12h) après dose de charge de 2g sur 30 min ou discontinue en 3 à 4 perfusions de 2g prolongées de 4h	
Méropénème		**IV :** 2 g toutes les 8 h en perfusions de 4h à 8h	
Linézolide		**IV ou PO**: 600 mg/ 12 h	Le STP peut être utile pour évaluer la toxicité hématologique
Clindamycine		**IV lente ou PO** : - poids <70 kg : 600mg/ 8h - poids> 70kg : 900 mg/ 8h	Pas d'IV directe
Métronidazole		**IV ou PO** : 500 mg / 8 h	
Lévofloxacine		**IV ou PO** : 500 mg / 12 h	

STP : suivi thérapeutique pharmacologique

Synthèse réalisée par la SPILF

Posologies recommandées chez l'adulte (3)

Modalités d'administration des antibiotiques dans le cadre des infections cervicales profondes d'origine pharyngée chez l'adulte : posologies, voies d'administration, rythme, particularités : posologies, voies d'administration, rythme, particularités			
Antibiotique	**Adaptations :** fonction rénale, poids, modalité de s	**Posologie totale journalière de référence pour une fonction rénale normale (clairance entre 60 et 90 ml/min) et un IMC normal (entre 18 et 30 kg/ m²)**	**Particularités/ remarques**
Cotrimoxazole		**IV ou PO** : [320 mg triméthoprime + 1600 mg sulfaméthoxazole]/ 12h	
Gentamicine		**IV** : 6-7 mg/kg en perfusions de 30 min en dose unique journalière	Le STP doit guider l'adaptation des posologies.

I ndice de masse corporelle ; PO : per os; IV: Intra-veineux ; STP : suivi thérapeutique pharmacologique

= molécule s'adaptant à la fonction rénale, utilisation de l'outil « GPR » recommandé :http://sitegpr.com/fr/ et l est recommandé.

= molécule s'adaptant au poids, utilisation de l'outil abxbmi.com (http://abxbmi.com) et le STP est re nandé.

= molécules dont les modalités de perfusion peuvent être adaptées/ modifiées/ optimisée, utilisation des outils suivants recommandée :

Longuet P et al. Preparing and administering injectable antibiotics: How to avoid playing God. Med Mal Infect. 2016 (PMID: 27112521);
Diamantis S et al. Home intravenous antibiotherapy and the proper use of elastomeric pumps: Systematic review of the literature and proposals for improved use. Infect Dis Now. 2021 (PMID: 33576336).
https://www.sfm-microbiologie.org/wp-content/uploads/2024/06/CASFM2024_V1.0.pdf (page 164 à 177)

Traitements et posologies des antibiotiques chez l'enfant en fonction des situations (d'après les recommandations du GPIP)

Situations cliniques ***Cible bactériologique***	**Antibiotiques préférentiels** **(Traitement initial)**	**Alternatives en cas d'allergie vraie aux pénicillines[1]**	**Commentaires**
Adénite simple **(non hospitalisée)** *SGA* *S. aureus méti S* *(SAMS)*	Si TDR + : **Amoxicilline** (PO) 50 mg / kg / j en 2 fois (max 2 g / j) Si TDR – : **Amox-ac. clav** PO 80 mg / kg / j en 2 fois (max 3 g / j)	Si TDR + ou - **Clarithromycine** PO 15 mg / kg / j en 2 fois (max 500 mg / j) Ou Après 6 ans: **Clindamycine** (PO) 30 mg / kg / j en 3 fois (max 1,8 g / j)	L'utilisation des tests de diagnostic rapide du SGA (TDR) est conseillée dans les adénites cervicales si une antibiothérapie est envisagée : s'il est positif il permet de prescrire un antibiotique ciblant le streptocoque uniquement[2]

[1]Wijnakker R *et al*. 2023
[2]Wollner A *et al*, 2014

Traitements et posologies des antibiotiques chez l'enfant en fonction des situations (d'après les recommandations du GPIP)

Situations cliniques ***Cible bactériologique***	**Antibiotiques préférentiels (Traitement initial)**	**Alternatives en cas d'allergie vraie aux pénicillines[1]**	**Relai oral**
Abcès péri-amygdalien **Abcès péri-pharyngé ou rétropharyngé** **Adénite aiguë suppurée grave** **Cellulite cervicale profonde** *SGA* *SAMS* *S. pneumoniae* *Fusobacterium spp* *Bacteroïdes spp*	**Amox-ac. clav[2]** 150 mg/kg/j en 3 fois (max 4 g / j) + **Clindamycine** si signes toxiniques 40 mg/kg/j en 4 inj (max 2,4 g / j)	**Cefotaxime** 200 mg/kg/j en 3 inj (max 12 g / j) + **Clindamycine** si signes toxiniques 40 mg/kg/j en 4 inj (max 2,4 g / j) Ou **Métronidazole** 30 mg /kg/j en 3 inj (max 1,5 g / j) En cas de contre indication à toutes les beta lactamines : Avis infectiologique	Fonction de la documentation microbiologique En l'absence de documentation microbiologique : 1 - **Amoxicilline/ac. clav** 2 - **Clindamycine** (en gélule ouvrable dans une compote) 3 – **Linézolide** (suspension buvable) < 5 ans : 30mg/kg/j en 3 prises > 5 ans : 20mg/kg/j en 2 prises Relais PO possible dès évolution clinique favorable[3]

[1] Wijnakker R et al. 2023

[2] PO d'emblée envisageable en cas d'abcès amygdalien uniquement; si troubles de la déglutition modérés, absence de trismus et de signes de gravité hémodynamique

[3] Evolution clinique favorable : Apyrexie, reprise de la voie orale

Durée d'antibiothérapie adulte et enfant

- Adénite : 7 jours (enfant 10 jours)

- Abcès péri ou rétro pharyngé drainé : 7 jours
- Abcès péri ou rétro pharyngé non drainé : 10 jours (enfant 14 jours)

- Abcès péri-amygdalien drainé : 7 jours
- Abcès péri-amygdalien non drainé : 10 jours

- Cellulite cervicale profonde extensive : 14 jours post chirurgie

- Médiastinite nécrosante descendante : 14 jours post chirurgie